

RECOMMANDATIONS POUR LA PRISE EN CHARGE DES EFFETS INDÉSIRABLES DU MALATE DE SUNITINIB (SUTENT^{MD})

Le malade de sunitinib (SUTENT^{MD}) est un inhibiteur de cibles enzymatiques multiples ayant une activité tyrosine kinase qui possède à la fois des propriétés antiprolifératives et antiangiogéniques importantes chez les patients atteints d'un adénocarcinome rénal métastatique ou d'une tumeur stromale gastro-intestinale. La marge d'innocuité et de tolérabilité du sunitinib a été relativement constante dans l'ensemble des études cliniques et des populations de sujets atteints de tumeurs malignes solides, notamment de tumeur stromale gastro-intestinale et d'adénocarcinome rénal métastatique. Bien que le sunitinib soit généralement bien toléré certains effets indésirables requièrent une surveillance pour identifier des conditions traitables ou nécessitant une modification de dose. Veuillez noter que ce document passe en revue des effets indésirables observés dans le cadre des essais cliniques sur le sunitinib et les recommandations relatives à leur prise en charge, fondées sur les données disponibles.

Les patients traités par le sunitinib doivent être sous la surveillance d'un médecin qualifié ayant de l'expérience dans l'administration des antinéoplasiques¹. On doit informer les patients qui amorcent un traitement par le sunitinib du risque d'effets indésirables liés au traitement et de la façon de reconnaître ces manifestations. On doit encourager les patients à surveiller leur état de santé et à rapporter tout effet indésirable à leur équipe de soins le plus tôt possible. Le fait d'identifier les effets indésirables liés au traitement et d'intervenir rapidement peut permettre d'éviter de réduire la dose ou d'en différer la prise et d'atténuer l'inconfort des patients. Une évaluation et une prise en charge proactives des effets indésirables aideront à optimiser le traitement par le sunitinib.

L'information contenue dans ce document porte sur les effets indésirables les plus souvent associés au sunitinib et/ou les manifestations pour lesquelles figurent des recommandations dans la monographie du produit, la littérature médicale ou le programme clinique. Les manifestations indésirables et leur fréquence ne sont pas décrites dans ce document mais le sont dans la section EFFETS INDÉSIRABLES de la monographie de produit. Veuillez consulter la section MISES EN GARDE ET PRÉCAUTIONS de la monographie du sunitinib pour obtenir plus de renseignements sur la prise en charge des problèmes d'innocuité qui ne sont pas énumérés ci-dessous.

PRISE EN CHARGE DES EFFETS INDÉSIRABLES

Les effets indésirables sont énumérés en ordre alphabétique ci-dessous. Les recommandations visant à aider la prendre en charge des effets indésirables du sunitinib y sont incluses.

Anorexie

- L'anorexie nécessite rarement d'avoir à modifier la dose ou à en différer la prise. Il faut chercher la cause sous-jacente de toute perte de poids supérieure à > 2,3 kg (5 lb)².
- On suggère d'organiser une consultation en diététique et de bien renseigner le patient sur les aliments qui ne favorisent pas d'autres effets indésirables, tels la diarrhée.
- Peut être secondaire à une stomatite ou à une mucosite (d'après une consultation d'experts).

Complications hémorragiques

- On peut envisager de suspendre temporairement le traitement par le sunitinib ou de différer l'administration du médicament jusqu'à ce que l'on ait déterminé la cause de l'hémorragie.
- L'évaluation systématique des complications hémorragiques devrait inclure une série d'héogrammes et un examen physique¹.

- Il n'est pas nécessaire d'interrompre l'administration du sunitinib en cas d'épistaxis, pourvu qu'il n'y ait pas de signes de thrombocytopénie (d'après une consultation d'experts).

Diarrhée

- La diarrhée peut être traitée par une bonne hydratation orale et la prise au besoin d'antidiarrhéiques par voie orale comme le lopéramide^{1,3,4}.
- On doit indiquer aux patients de s'abstenir temporairement de prendre des laxatifs émollients et certains suppléments de fibres.
- Conseiller aux patients de boire beaucoup de liquides (mais de petites quantités à la fois), de manger et de boire souvent en petites quantités et d'éviter les aliments épicés ou gras, la caféine et les aliments à forte teneur en fibres. Ils doivent aussi éviter de boire de grandes quantités de liquides avec les repas et pendant 1 heure après avoir mangé, si possible.
- On doit envisager d'interrompre le traitement avec le sunitinib ou de modifier la dose dans les cas de toxicité de grade 3.

Fatigue

- Une déshydratation sous-jacente risque d'entraîner de la fatigue ou de l'aggraver. On suggère de veiller à une hydratation et à une alimentation adéquates.
- On recommande de procéder à des examens de laboratoire et à une évaluation clinique pour écarter les autres causes possibles de fatigue comme l'hypothyroïdie, l'anémie ou la dépression² :
 - On recommande d'effectuer des évaluations en laboratoire de la fonction thyroïdienne au début du traitement puis tous les 2 à 3 mois durant le traitement par le sunitinib. L'hypothyroïdie doit être traitée au moyen des soins standards qui s'imposent^{1,5,6,7}.
 - L'anémie est une possibilité, et la surveillance des hémogrammes permettra de la déceler. On peut avoir recours à des agents érythropoïétiques tels que l'époétine-alpha ou la darbépoétine-alpha ou à une transfusion sanguine, à la discrétion du médecin traitant^{2,3}.
 - La dépression peut influencer sur l'intensité de la fatigue. La fatigue s'est atténuée chez certains patients ayant reçu des antidépresseurs ou du méthylphénidate.
- Conseillez aux patients :
 - De faire de petites siestes ou pauses.
 - De bien manger et de boire beaucoup.
 - De faire de la marche à pied sur de courtes distances ou de l'exercice de faible intensité.
 - D'avoir des activités relaxantes, comme écouter de la musique ou lire.
 - De ne pas conduire un véhicule ou de ne pas prendre les commandes d'une machine lorsqu'ils se sentent fatigués.

Contrôle de la glycémie des patients diabétiques

- Le contrôle de la glycémie peut parfois être affecté chez les diabétiques. Demandez à vos patients atteints de diabète de vérifier leur taux de glucose sanguin régulièrement.

Toxicité cutanée : Syndrome mains-pieds (érythrodysesthésie palmoplantaire)

- La présentation de ce syndrome diffère de celle observée durant la chimiothérapie (p. ex., capécitabine) (d'après une consultation d'experts).
- Les patients peuvent éprouver des symptômes (p. ex., douleur) sans présenter de changement morphologique ni de signe physique (d'après une consultation d'experts).

- Les stratégies de prise en charge du syndrome mains-pieds comprennent :
 - Différer le traitement bien plus souvent que de réduire la dose. Dans certains centres, on procède à une réévaluation de la gravité des symptômes après un cycle supplémentaire avant de réduire la dose de sunitinib.
 - Les crèmes et lotions hydratantes, les produits de soins pour les mains et les pieds (p. ex., les coussinets de gel, les gants de coton et les crèmes de propionate de clobétasol) ainsi que les analgésiques font partie des traitements palliatifs.
 - Les patients devraient veiller à diminuer la pression sur les régions touchées, en s'abstenant, quand c'est possible, de s'appuyer sur leurs pieds, et à éviter toute friction ou pression au niveau des mains. Pendant le traitement, on peut utiliser des coussinets amortisseurs pour soulager les points d'appui douloureux, et le port de sandales semblent aider certains patients⁸.
- Conseillez aux patients :
 - D'éviter le port de souliers serrés et la friction sur les mains et les pieds, telle que celle causée par une activité importante.
 - D'éviter de porter des bijoux serrés.
 - D'éviter de peler les ampoules car cela aggraverait l'affection.
 - De porter des vêtements en coton amples.
 - De se laver les mains et les pieds à l'eau tiède et de les sécher délicatement sans frotter; éviter l'eau chaude.
 - D'appliquer un écran solaire doté d'un FPS (facteur de protection solaire) d'au moins 30.
 - D'appliquer des crèmes à la lanoline sur leurs mains et pieds, abondamment et fréquemment, même avant le début de la thérapie.

Troubles hématologiques

- Il est recommandé de procéder à un hémogramme au début de chaque cycle de traitement par le sunitinib.
- Le tableau ci-dessous décrit les modifications de la dose recommandées en cas de troubles sanguins associés au traitement par le sunitinib dans les essais cliniques.

Toxicité	Grade 1	Grade 2	Grade 3	Grade 4
Hématologique	Continuer à la même dose.	Continuer à la même dose.	Différer la dose jusqu'à ce que la toxicité ait atteint un grade ≤ 2 ou la valeur de départ, puis reprendre le traitement à la même dose ^a .	Différer la prise de la dose jusqu'à ce que la toxicité ait atteint un grade ≤ 2 , puis réduire la dose d'un palier et reprendre le traitement ^b .

a Une lymphopénie ou une anémie de grade 3 ne nécessitent pas de modification de la dose. Une neutropénie ou une thrombocytopénie de grade 3 récurrentes persistant pendant au moins 5 jours requièrent une réduction de la dose lors du cycle suivant.

b Une lymphopénie de grade 4 ne nécessite aucune réduction de la dose.

- Neutropénie
 - Pour prévenir les infections, conseillez aux patients :
 - De se laver souvent les mains, notamment à chaque fois qu'ils vont aux toilettes.
 - D'éviter les foules et les personnes malades.
 - Les patients souffrant de neutropénie fébrile doivent être hospitalisés sans délai afin de recevoir une antibiothérapie par voie intraveineuse, et ils peuvent recevoir des facteurs de stimulation des colonies thérapeutiques, tel qu'il convient.

- Anémie
 - On peut avoir recours à des agents érythropoïétiques tels que l'époétine-alpha ou la darbépoétine-alpha ou à une transfusion sanguine, à la discrétion du médecin traitant^{2,3}.
- Thrombocytopénie
 - Pour éviter les troubles hémorragiques, conseillez aux patients :
 - D'éviter les coups, les coupures et les brûlures.
 - De se nettoyer le nez en se mouchant délicatement.
 - De traiter la constipation, le cas échéant.
 - Pour la douleur légère, on recommande l'acétaminophène (p. ex., TYLENOL^{MD}). Éviter l'AAS (p. ex., ASPIRINE^{MD}), l'ibuprofène (p. ex., ADVIL^{MD}) et tout autre agent anti-inflammatoire non stéroïdien, puisqu'ils peuvent augmenter le risque de saignements.
 - De se brosser les dents délicatement au moyen d'une brosse à dents douce afin d'éviter d'irriter les gencives. Maintenir une bonne hygiène buccale.

Hyperamylasémie et hyperlipasémie

- On décrit dans le tableau ci-dessous les modifications de la dose recommandées dans les cas de variations du taux d'amylase ou de lipase sérique associées au sunitinib durant les essais cliniques.

Toxicité	Grade 1	Grade 2	Grade 3	Grade 4
Hyperamylasémie ou hyperlipasémie sans symptôme clinique de pancréatite	Continuer à la même dose.	Continuer à la même dose.	Continuer à la même dose.	Différer la prise de la dose jusqu'à ce que la toxicité ait atteint un grade ≤ 3, puis reprendre le traitement.

Hypertension

- Il faut surveiller les patients afin de déceler toute apparition d'une hypertension et de la traiter, le cas échéant, au moyen d'un antihypertenseur standard.
- Les antihypertenseurs standards peuvent inclure :
 - les inhibiteurs de l'enzyme de conversion de l'angiotensine,
 - les antagonistes des récepteurs de l'angiotensine,
 - les bloqueurs des canaux calciques,
 - les bêtabloquants et
 - les diurétiques.
- Pour obtenir plus d'information, veuillez consulter les recommandations de la Société canadienne d'hypertension. Ces lignes directrices peuvent être consultées à l'adresse suivante : www.hypertension.ca (dernière visite : 28/02/2006). En général, selon les lignes directrices, on recommande de traiter l'hypertension à l'aide d'un agent antihypertenseur en visant une cible < 140/90 mmHg et < 130/80 mmHg chez les patients atteints de diabète ou de néphropathie chronique.
- Certains antihypertenseurs peuvent interagir avec le sunitinib :
 - On recommande d'éviter d'administrer le sunitinib en concomitance avec des inhibiteurs de la CYP3A4, notamment les bloqueurs des canaux calciques, comme le diltiazem et le vérapamil, qui sont de puissants inhibiteurs de la CYP3A4.
 - On doit faire preuve de prudence si l'on prescrit le sunitinib à des patients en concomitance avec d'autres médicaments qui entraînent eux aussi une prolongation de l'intervalle PR, tels

les bêtabloquants et les bloqueurs des canaux calciques¹. Les bloqueurs des canaux calciques de la classe des dihydropyridines sont également associés à un faible risque d'œdème périphérique. Ces agents dilatent principalement la portion précapillaire du tronc vasculaire, augmentant ainsi le gradient de pression transcapillaire, ce qui force le liquide du lit vasculaire vers les tissus et entraîne un œdème^{9,10,11}.

- On recommande de suspendre temporairement le traitement par le sunitinib dans les cas d'hypertension grave. Le traitement avec le sunitinib peut être repris une fois l'hypertension maîtrisée.
- Les patients dont l'hypertension n'est pas maîtrisée par une médication antihypertensive doivent cesser de recevoir le sunitinib. Toutefois, aucun cas d'hypertension n'a nécessité l'arrêt du traitement par le sunitinib lors des essais cliniques.
- Durant le traitement par le sunitinib, il peut être nécessaire de procéder au réglage posologique des antihypertenseurs chez les patients qui souffrent d'une hypertension préexistante. Dans cette population de patients, on suggère également de mesurer quotidiennement la tension artérielle (TA) à domicile et de consigner les données sur la TA dans un journal.
- **Consultez le tableau ci-dessous pour obtenir une description plus détaillée de l'emploi d'antihypertenseurs pour traiter l'hypertension attribuable au traitement par le sunitinib. Les agents en caractères gras représentent les meilleurs choix pour éviter les interactions médicamenteuses avec le sunitinib par l'intermédiaire du cytochrome P450 ou d'en réduire le risque¹².**

Tous les antihypertenseurs ci-dessous sont pris par voie orale.

Inhibiteurs de l'enzyme de conversion de l'angiotensine

Agent	Dose initiale	Dose intermédiaire	Dose maximale	Métabolisme hépatique
Captopril	12,5 mg 3 f.p.j.	25 mg 3 f.p.j.	50 mg 3 f.p.j.	Substrat de la CYP2D6
Énalapril	5 mg 1 f.p.j.	10-20 mg 1 f.p.j.	40 mg 1 f.p.j.	Substrat de la CYP3A4
Ramipril	2,5 mg 1 f.p.j.	5 mg 1 f.p.j.	10 mg 1 f.p.j.	Oui (CYP450 inconnue)
Lisinopril	5 mg 1 f.p.j.	10-20 mg 1 f.p.j.	40 mg 1 f.p.j.	Non
Fosinopril	10 mg 1 f.p.j.	20 mg 1 f.p.j.	40 mg 1 f.p.j.	Oui (CYP450 inconnue)
Périndopril	4 mg 1 f.p.j.	Aucune	8 mg 1 f.p.j.	Oui mais pas CYP450
Quinapril	10 mg 1 f.p.j.	20 mg 1 f.p.j.	40 mg 1 f.p.j.	Non

Bloqueurs des récepteurs de l'angiotensine II

Agent	Dose initiale	Dose intermédiaire	Dose maximale	Métabolisme hépatique
Losartan	25 mg 1 f.p.j.	50 mg 1 f.p.j.	100 mg 1 f.p.j.	Substrat de la CYP3A4
Candésartan	4 mg 1 f.p.j.	8-16 mg 1 f.p.j.	32 mg 1 f.p.j.	Substrat de la CYP2C9
Irbésartan	75 mg 1 f.p.j.	150 mg 1 f.p.j.	300 mg 1 f.p.j.	Substrat de la CYP2C9
Telmisartan	40 mg 1 f.p.j.	Aucune	80 mg 1 f.p.j.	Oui mais pas CYP450
Valsartan	80 mg 1 f.p.j.	Aucune	160 mg 1 f.p.j.	Oui mais pas CYP450

Bloqueurs des canaux calciques de la classe des dihydropyridines

Agent	Dose initiale	Dose intermédiaire	Dose maximale	Métabolisme hépatique
Nifédipine XL	30 mg 1 f.p.j.	60 mg 1 f.p.j.	90 mg 1 f.p.j.	Substrate+ inhibiteur de la CYP3A4

Amlodipine Féلودىپىنة	2,5 mg 1 f.p.j. 2,5 mg 1 f.p.j.	5 mg 1 f.p.j.	10 mg 1 f.p.j. 10 mg 1 f.p.j.	Substrat de la CYP3A4 Substrat de la CYP3A4
--------------------------	------------------------------------	---------------	----------------------------------	--

Alphabloquants et bêtabloquants

Agent	Dose initiale	Dose intermédiaire	Dose maximale	Métabolisme hépatique
Labétolol	100 mg 2 f.p.j.	200 mg 2 f.p.j.	400 mg 2 f.p.j.	Substrat + inhibiteur de la CYP2D6

Bêtabloquants sélectifs

Agent	Dose initiale	Dose intermédiaire	Dose maximale	Métabolisme hépatique
Métoprolol	25 mg 2 f.p.j.	50 mg 2 f.p.j.	100 mg 2 f.p.j.	Substrat de la CYP2D6
Aténolol	25 mg 1 f.p.j.	50 mg 1 f.p.j.	100 mg 1 f.p.j.	Non
Acébutolol	100 mg 2 f.p.j.	200-300 mg 2 f.p.j.	400 mg 2 f.p.j.	Oui (CYP450 inconnue)
Bisoprolol	2,5 mg 1 f.p.j.	5-10 mg 2 f.p.j.	20 mg 1 f.p.j.	Oui (CYP450 inconnue)

Diurétique

Agent	Dose initiale	Dose intermédiaire	Dose maximale	Métabolisme hépatique
Hydrochlorothiazide	10 mg 1 f.p.j.	20 mg 1 f.p.j.	40 mg 1 f.p.j.	Non

Dysfonctionnement ventriculaire gauche

- Durant un traitement par le sunitinib, il faut surveiller étroitement les patients exposés à des facteurs de risque cardiaque afin de déceler tout signe ou symptôme d'insuffisance cardiaque. On doit également envisager de procéder à des évaluations initiales et périodiques de la fraction d'éjection ventriculaire gauche (FEVG) durant le traitement par le sunitinib chez ces patients.
- Chez les patients exempts de facteurs de risque cardiaque, il est conseillé d'évaluer la fraction d'éjection au départ.
- En présence de signes cliniques d'insuffisance cardiaque, il est recommandé de mettre fin au traitement par le sunitinib. Chez les patients exempts de signes d'insuffisance cardiaque, mais dont la fraction d'éjection est < 50 % et inférieure de > 20 % à la fraction initiale, il faut interrompre l'administration du sunitinib ou en réduire la dose.
- On décrit dans le tableau ci-dessous les modifications de la dose recommandées dans les cas de toxicité cardiaque associée au sunitinib.

Toxicité	Grade 1	Grade 2	Grade 3	Grade 4
Toxicité cardiaque	Continuer à la même dose.	Continuer à la même dose sauf en cas de : • Diminution asymptomatique de la FEVG par une valeur absolue de 20 % et jusqu'à une valeur inférieure à la LIN • Trouble du rythme ventriculaire paroxystique non urgent nécessitant une intervention Différer la prise de la dose jusqu'à ce que la toxicité ait atteint un grade ≤ 1 , puis réduire la dose de 1 palier et reprendre le traitement.	Différer la prise de la dose jusqu'à ce que la toxicité ait atteint un grade ≤ 1 ou la valeur de départ, puis réduire la dose de 1 palier et reprendre le traitement ^a .	Mettre fin au traitement par le sunitinib.

a Les patients atteints d'insuffisance cardiaque congestive doivent cesser le traitement par le sunitinib.

LIN = Limite inférieure de la normale

Nausées et vomissements

- Les effets indésirables gastro-intestinaux devant être traités pourront l'être à l'aide d'antiémétiques.
- Il peut également être utile d'administrer un traitement prophylactique par un antiémétique pour limiter les nausées et vomissements liés au traitement.
- Cependant, il faut être particulièrement vigilant quand on administre le sunitinib avec des médicaments contre les troubles digestifs (p. ex., dompéridone, antagonistes des récepteurs 5-HT₃ tels que granisétron, ondansétron, dolasétron), ces médicaments pouvant avoir été associés à une prolongation de l'intervalle QT/QTc et/ou à des torsades de pointes.
- Il est plus facile de prévenir les nausées que de les traiter une fois qu'elles sont apparues. On doit recommander aux patients de boire beaucoup de liquide, et de manger et de boire souvent, en petites quantités.

Complications buccales, stomatite, mucosite et brûlures d'estomac

- Les patients peuvent éprouver des symptômes (p. ex., douleur) sans présenter de modification morphologique ni de signe physique (d'après une consultation d'experts).
- Le traitement des effets indésirables buccaux est en général palliatif et peut comprendre : les rince-bouches sans alcool, la lidocaïne visqueuse, les dentifrices sans peroxyde, et les onguents et baumes pour les lèvres en cas de chéilite. On recommande le rabéprazole pour le traitement des brûlures d'estomac (d'après une consultation d'experts).
- On devrait conseiller aux patients de se rincer la bouche plusieurs fois par jour au moyen d'un rince-bouche maison sans alcool constitué de ½ cuillerée à thé de bicarbonate de soude ou de sel dilué dans 1 tasse d'eau chaude.
- Il peut également être utile de renoncer à certaines habitudes alimentaires et d'éviter, par exemple, la nourriture épicée, les aliments acides, la prise d'aliments à des températures extrêmes et l'alcool; on peut aussi conseiller de manger des aliments mous.
- Conseillez aux patients :
 - o De se brosser les dents délicatement après avoir mangé et avant de se coucher au moyen d'une brosse à dents très douce.

- En cas de saignement des gencives, utiliser une gaze plutôt qu'une brosse à dents. Remplacer le dentifrice par du bicarbonate de soude.
- De boire avec une paille.

Effets sur la coloration de la peau ou des cheveux

- La peau et/ou l'urine peuvent jaunir. Les cheveux peuvent perdre leur couleur naturelle et devenir blancs ou gris.
- Il n'existe pas de mesures indiquées en cas de changement de coloration de la peau ou des cheveux.
- Il faut informer les patients qu'une dépigmentation des cheveux ou de la peau peut se produire durant un traitement par le sunitinib.
- Les effets blanchissants des cheveux avec sunitinib peuvent être liés à l'inhibition de voies de signalisation multiples, notamment KIT, PDGFR et VEGFR sur les cellules endothéliales cutanées. Il est intéressant de noter que les cheveux gris peuvent être considérés comme un marqueur substitut potentiel pour surveiller l'observance du traitement par le sunitinib et ses effets biologiques^{8,13}.

Éruptions et sécheresse cutanées

- Les lotions hydratantes peuvent aider à empêcher la peau de s'assécher et soulager les symptômes d'éruption cutanée.
- On peut recommander aux patients de porter des vêtements amples en coton.

INTERACTIONS AVEC LE SUNITINIB

Interactions médicamenteuses

Le sunitinib est métabolisé principalement par l'isoenzyme CYP3A4. Il existe un risque d'interactions avec les médicaments qui sont des inhibiteurs ou des inducteurs de cette isoenzyme. On recommande de passer en revue les médicaments actuels du patient avant d'établir la posologie du sunitinib afin de réduire le risque d'interactions avec les médicaments pris en concomitance, comme les inducteurs ou les inhibiteurs de la CYP3A4.

En général, lorsqu'on administre des médicaments classés comme « substrats » en concomitance avec le sunitinib, il existe un risque d'élévation de la concentration du substrat. Il est préférable d'éviter l'administration de sunitinib en concomitance avec des médicaments dotés d'un intervalle thérapeutique étroit qui sont des substrats de la CYP3A4. Lorsqu'on administre le sunitinib en concomitance avec des agents classés comme des « inhibiteurs », il peut s'ensuivre une hausse de la concentration plasmatique du sunitinib; on recommande d'éviter l'administration concomitante de sunitinib et d'inhibiteurs de la CYP3A4. En revanche, l'administration concomitante d'« inducteurs » peut potentiellement abaisser la concentration plasmatique du sunitinib et on doit également éviter d'administrer le sunitinib en concomitance avec des inducteurs de la CYP3A4.

On énumère dans le tableau ci-dessous les médicaments susceptibles d'interagir avec le sunitinib. Notez que seules les interactions médicamenteuses entre le sunitinib et le kétoconazole (inhibiteur de la CYP3A4)¹⁴ et la rifampicine (inducteur de la CYP3A4) ont fait l'objet de preuves scientifiques¹⁵. Tous les autres médicaments cités ci-dessous pourraient hypothétiquement interagir avec le sunitinib, mais n'ont pas été évalués pour l'instant. Il existe également un risque d'interaction entre le sunitinib et d'autres substrats du cytochrome P450 (CYP3A4) qui n'ont pas été mentionnés ni étudiés. Veuillez consulter la monographie du sunitinib pour obtenir toute l'information sur les interactions médicamenteuses et l'intervalle QT/QTc.

Inhibiteurs de la CYP 3A4 ^{16,17}			
Acétazolamide Amiodarone Amprénavir Anastrozole ^a Aprépitant ^b Atazanavir Azélastine ^b Cannabidiol (puissant) Cannabinoïdes Cérvastatine ^b Cimétadine Cisapride ^b Citalopram ^a Clarithromycine Clémastine ^b Clofazimine ^b Clotrimazole Cyclosporine Danazol Délavirdine Dexmédétomidine ^b	Dihydroergotamine Diltiazem Docétaxel Doxycycline Drospirénone Éfavirenz Énoxacine ^b Entacapone Ergotamine Érythromycine (puissant) Éthinylestradiol Étoposide Fluconazole Fluoxétine Fluvoxamine Fosamprenavir Glyburide Jus de pamplemousse Hydralazine Imatinib (puissant) Indinavir Isoniazid	Isradipine Itraconazole (puissant) Kétoconazole (puissant) Méfloquine Mestranol Méthimazole Méthoxsalen Métronidazole Miconazole Mifépristone ^b Mitoxantrone Néfazodone (puissant) Nelfinavir Nicardipine ^b Nifédipine Nisoldipine ^b Nitrendipine ^b Norfloxacin Olanzapine ^a Orphénadrine Oxybutynine Paclitaxel	Pentamidine Pergolide Phencyclidine ^b Pilocarpine Pimozide Propranolol Quinidine Quinine Quinupristine Ranitidine ^a Ritonavir (puissant) Saquinavir Sertraline ^a Sildénafil ^a Sulconazole ^b Télithromycine Tétracycline Ticlopidine Troléandomycine Verapamil Zafirlukast (mineur) Ziprasidone ^b

Inducteurs de la CYP3A4 ^{16,17}			
Aminoglutéthimide ^b Barbituriques Bosentan Carbamazépine Corticostéroïdes	Dexaméthasone Éthosuximide Fosphénytoïne Modafinil Névirapine	Oxcarbazépine Pentobarbital Phénobarbital Phénylbutazone Phénytoïne	Prednisone Primidone Rifabutine Rifampicine Rifapentine ^b Millepertuis

a Inhibiteur faible, peu susceptible de causer des problèmes aux concentrations cliniques habituelles.

b Pas sur le marché canadien

Interactions avec les aliments et les produits médicinaux

- Étant donné que le jus de pamplemousse exerce un effet inhibiteur sur la CYP3A4, son ingestion durant un traitement par le sunitinib peut entraîner une baisse de la biotransformation du sunitinib et faire augmenter la concentration plasmatique du médicament. Il est conseillé d'éviter de boire du jus de pamplemousse durant le traitement par le sunitinib.
- Le millepertuis est un puissant inducteur de la CYP3A4. Son administration à des patients traités par le sunitinib peut entraîner une biotransformation accrue du sunitinib et une baisse de la concentration plasmatique du médicament. Il est conseillé d'éviter de prendre du millepertuis durant le traitement par le sunitinib.

- D'après le *Drug Interaction Facts*, seuls le millepertuis et le jus de pamplemousse sont mentionnés comme possédant un risque d'interaction avec le sunitinib. Aucune donnée n'a été relevée dans la littérature médicale au sujet de ces interactions potentielles¹⁸.

Autres médicaments concomitants

- L'usage d'anticoagulants dérivés de la coumarine, telle la warfarine, n'est pas recommandé, bien que des doses pouvant atteindre 2 mg par jour soient permises dans la prophylaxie de la thrombose.
- On peut prescrire d'autres traitements concomitants considérés comme nécessaires pour le bien-être du patient, à la discrétion du médecin.

MODIFICATIONS DE LA DOSE

On a observé un certain nombre d'effets indésirables attribuables au sunitinib chez des patients traités en raison de tumeurs solides, comme l'adénocarcinome rénal métastatique ou les tumeurs stromales gastro-intestinales. La plupart des effets indésirables sont réversibles et ne requièrent pas l'arrêt du traitement par le sunitinib. Au besoin, on peut prendre en charge ces manifestations en ajustant la dose ou en différant la prise du médicament. On recommande de modifier la dose par paliers de 12,5 mg, en fonction de l'innocuité et de la tolérabilité. Habituellement, si plus de deux réductions de la dose sont nécessaires, il est préférable d'interrompre le traitement par le sunitinib. Un retour à un degré de toxicité acceptable doit se produire en 4 semaines pour permettre la reprise du traitement par le sunitinib. On peut reporter de 2 semaines l'amorce du cycle de traitement suivant par le sunitinib si un délai additionnel est nécessaire pour permettre au patient de se remettre de la toxicité associée au traitement durant le cycle actuel. On suggère d'augmenter la dose par paliers jusqu'à la dose antérieure en l'absence d'effets indésirables hématologiques de grade ≥ 3 ou d'effets indésirables non hématologiques de grade ≥ 2 liés au traitement pendant le cycle précédent. En général, le jugement clinique, appuyé sur les antécédents médicaux et l'état clinique du patient, dictera la surveillance et les mesures indiquées, s'il y a lieu, pour corriger les effets indésirables.

Références

- ¹ Pfizer Canada Inc., monographie de SUTENT, 16 août 2006.
- ² Creel T *et al.* Nursing perspectives on adverse event (AE) management for sunitinib, an oral, multitargeted tyrosine kinase inhibitor, in patients with renal cell carcinoma (RCC) and gastrointestinal stromal tumor (GIST). 14th International Conference on Cancer Nursing; 27 September-1 October 2006; Toronto, Ontario, Canada [affiche].
- ³ SUTENT Protocol A6181034. A phase 3, randomized study of SU011248 versus interferon- α as first-line systemic therapy for patients with metastatic renal cell carcinoma. Amendment #4. February 20, 2006.
- ⁴ Motzer RJ *et al.* Sunitinib in patients with metastatic renal cell carcinoma. *JAMA* 2006;295(21):2516-24.
- ⁵ Desai *et al.* Hypothyroidism after sunitinib treatment for patients with gastrointestinal stromal tumors. *Ann Int Med* 2006;145:660-664.
- ⁶ Rini *et al.* Hypothyroidism in patients with metastatic renal cell carcinoma treated with sunitinib. *JCNI* 2007;99:81-83.
- ⁷ Shaheen PE *et al.* Thyroid function tests (TFTs) abnormalities in patients (pts) with metastatic renal cell carcinoma (mRCC) treated with sunitinib. *J Clin Oncol* 2006;24(18S Pt 1):242s [résumé].
- ⁸ Robert C *et al.* Cutaneous side-effects of kinase inhibitors and blocking antibodies. *Lancet* 2005;6:491-9.
- ⁹ Dougall HT *et al.* A comparative review of the adverse effects of calcium antagonists. *Drug Safety* 1996;15(2):91-106.
- ¹⁰ Cross BW *et al.* A multicentre study of the safety and efficacy of amlodipine in mild to moderate hypertension. *Br J Clin Pract* 1993;47(3):237-40.
- ¹¹ Pedrinelli R *et al.* Amlodipine, enalapril, and dependent leg edema in essential hypertension. *Hypertension* 2000;35:621-5.
- ¹² ECOG trial. A randomized, double-blind phase III trial of adjuvant sunitinib versus sorafenib versus placebo in patients with resected renal cell carcinoma.
- ¹³ Faivre S *et al.* Safety, pharmacokinetic, and antitumor activity of SU11248, a novel oral multitarget tyrosine kinase inhibitor, in patients with cancer. *J Clin Oncol* 2006;24(1):25-35.
- ¹⁴ Washington C *et al.* The effect of ketoconazole (KETO), a potent CYP3A4 inhibitor, on SU011248 pharmacokinetics (PK) in caucasian and Asian healthy subjects. *Proc Am Soc Clin Oncol* 2003;22:138. [abstract]
- ¹⁵ Bello CL *et al.* The effect of rifampin on the pharmacokinetics of sunitinib malate (SU11248) in Caucasian and Japanese populations. *Eur J Cancer Suppl* 2005 3(2):430. [résumé]

-
- ¹⁶ Cytochrome P-450 Enzymes and Drug metabolism. In: Lacy CF, Armstrong LL, Goldman MP, Lance LL eds. Drug Information Handbook 12TH ed. Hudson, OH; LexiComp Inc. 2004: 1619-1631.
- ¹⁷ Canadian Pharmacists Association. Compendium of Pharmaceuticals and Specialties. XXth ed. Ottawa, Ont. The Association; 2006. [online]. <<https://www.e-therapeutics.ca/wps/portal/!ut/p/.scr/Login>>. Cité [8 déc. 2006].
- ¹⁸ Tatro DS (Ed.). Drug Interaction Facts, 4th ed; Facts and Comparisons: St. Louis, MO, 2005.